

Қалқанша без обырындағы орын басушы гормонды ем және тиреоидты статус

Масадыков А.С., Гарипова А.Р., Жунусов Г.А.
Семей қаласы Өңірлік онкологиялық диспансері

Қалқанша без обырындағы орын басушы гормонды ем және тиреоидты статус

А.С. Масадыков, А.Р. Гарипова, Г.А. Жунусов

Зерттеудің мақсаты – қалқанша бездің түйінді ісіктері бойынша жасалған операциялар көлемінің орын басушы ем жүргізу барысында тиреоидты статусқа әсерін зерттеп білу.

Қалқанша бездің түйінді патологиясы бойынша операция жолымен емделіп, операциядан кейінгі кезеңде орын басушы ем алған 225 науқастың тиреоидты статус көрсеткішіне талдау жүргізілді. Операция жасалған сәттен қаралғанға дейінгі мерзімге байланысты барлық науқастар 7 топқа бөлінді: тікелей операциядан кейін (1 айға дейін); 6 айға дейін; 1 жылға дейін; 2 жылға дейін; 3 жылға дейін; 5 жылға дейін; және 5 жылдан жоғары.

Қортынды: Тиреоидэктомия жасалған науқастарда тиреоидты статусының үдемелі төмендеуі және тіпті жүргізілген орын басушы ем фонында операциядан кейінгі аяқ мерзімде гипопитарлы реттеуші механизмдер дисбалансының өсуі байқалады.

Қалқанша бездің қызметін атқарушы парнехиманың шағын ғана көлемін сақтау науқастардың тиреоидты статусын анағұрлым арттыруға ықпал етеді.

Қалқанша бездің бір ғана белгілі қызметі тиреоидты гормондарды өндіру болып табылады [1]. Оның бұзылуы бүкіл ағзада маңызды патологиялық өзгерістер туғызады. Сонда да бездің қызмет ететін парнехимасын толық алып тастағаннан кейін де тиреоидты гормондар препаратымен орын басушы ем жүргізу олардың өз өнімінің болмауының орнын толығымен басады деп есептеледі [2].

Бірақ қалқанша бездеріне радикалды және кеңейтілген операция жасалған науқастардың шынайы жағдайы көбіне олардың қанындағы тиреотропты гормондар концентрациясының жоғарылауымен байқалатын гипотиреоидты жағдайлардың дамуының анағұрлым жиілігі туралы нақтылайды [3,4]. Өз кезегінде бұл әсіресе, әйел адамдарда гипоталамо-гипофизарлы реттеудің ортақ механизмдеріне қатысты жағымсыз әсерлер кешенінің дамуына әкеледі [5].

Орын басушы ем тиімділігінің жеткіліксіз себебі мен

1-кесте. Қалқанша бездің алып тасталған парнехимасының көлеміне байланысты тиреоидты статус көрсеткіштері

Клиникалық топтар	Гормондар құрамы		
	T3	T4	ТТГ
Бақылау, n=30	2,20±0,13	125,2±9,5	1,8±0,1
Тиреоидэктомия, n=38	0,55±0,06**	40,3±3,8**	4,9±0,5**
Субтотальды резекция, n=43	0,68±0,10**	51,5±4,1**	3,6±0,3*
Органсақтаушы операциялар:			
алып тастау 50% жоғары парнехималар, n=46	0,79±0,09**	64,8±5,5**	3,1±0,3*
алып тастау 25-50% парнехималар, n=51	1,14±0,11**	83,5±7,0*	3,0±0,2**
алып тастау 25% төмен парнехималар, n=47	1,56±0,14*	97,5±7,3*	2,8±0,2*
Склеротерапия, n=50	2,13±0,17	107,5±9,6	2,2±0,1*
Ескерту - * - бақылау тобы көрсеткіштерімен айырмашылық нақты, p<0,05, ** - p<0,01			

Substitutive Hormonotherapy In Presence Of Thyroid Gland Cancer And Thyroidal Status.

A.S. Masadykov, A.R. Garipova, G.A. Zhunusov

Purpose of research: investigation of correlation of surgery's volume to thyroid status in patients with replacement therapy.

Thyroid status was analyzed in 225 patients with nodal pathologies undergone to surgery and to whom replacement therapy was performed. All the patients were divided into 7 groups according to the term which lasted from the time of surgery until current investigation: just after surgery (within 1 month), up to 6 months, up to 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, and more than 5 years.

Conclusions: In patients undergone total thyroidectomy progressive decrease of thyroid status and misbalance of hypophyseal regulation mechanisms at the terms long after surgery have been observed in spite of replacement therapy. The patient with some thyroid tissue conserved thyroid status has been significantly higher.

оны түзеу жолдары бүгінгі күнге дейін толық зерттеліп болған жоқ.

Осыдан келіп, зерттеудің мақсаты орын басушы ем жүргізу барысында қалқанша бездің түйінді ісіктері бойынша жасалған операциялар көлемінің тиреоидты статусқа әсерін зерттеп білу болып табылады.

Материалдар мен әдістер

Аталмыш бөлім шеңберінде қалқанша бездің түйінді патологиясы бойынша операция жолымен емделіп, операциядан кейінгі кезеңде орын басушы ем алған 225 науқастың тиреоидты статус көрсеткішіне талдау жүргізілді. Бақылау тобы ретінде осы жас құрамындағы денсаулығы дұрыс 30 тексерілді, салыстыру тобы ретінде қалқанша бездің кейбір түйінді ісіктеріне склероздаушы ем жүргізілген 50 науқас тексерілді.

Операция жасалған сәттен қаралғанға дейінгі мерзімге байланысты барлық науқастар 7 топқа бөлінді: тікелей операциядан кейін (1 айға дейін); 6 айға дейін; 1 жылға дейін; 2 жылға дейін; 3 жылға дейін; 5 жылға дейін; және 5 жылдан жоғары.

Зерттеу нәтижелері

және оларды талдау

Операция көлеміне байланысты тексерілген науқастардың жалпы

2 – кесте. Қалқанша бездің қызметін атқарушы паренхиманың әртүрлі көлемі бар науқастардағы емделгеннен кейінгі мерзімге байланысты тиреоидты статус көрсеткіштері.

Клиникалық топтар мен тексерілу мерзімі	Гормондар құрамы		
	T3	T4	ТТГ
Тиреоидэктомия:			
операциядан кейін	2,18±0,13	133,5±9,5	2,1±0,2
6 ай	0,23±0,02	96,8±10,2	2,5±0,4
1 жыл	0,15±0,01	55,9±7,4	3,9±0,7
2 жыл	0,14±0,01	51,0±6,1	4,8±0,7
3 жыл	0,14±0,01	43,5±5,4	6,4±0,9
5 жыл	0,13±0,01	39,8±4,8	7,5±1,0
5 жылдан жоғары	0,14±0,01	37,3±4,0	7,7±1,2
Субтотальды резекция:			
операциядан кейін	2,27±0,14	141,7±10,1	2,0±0,2
6 ай	0,55±0,05	102,4±10,8	2,3±0,4
1 жыл	0,49±0,03	93,9±12,4	2,9±0,5
2 жыл	0,61±0,04	87,6±10,5	3,2±0,5
3 жыл	0,66±0,05	77,1±9,6	4,1±0,6
5 жыл	0,59±0,05	75,8±9,1	4,3±0,6
5 жылдан жоғары	0,64±0,05	80,3±8,6	4,4±0,7
Органды сақтаушы операциялар:			
операциядан кейін	2,13±0,10	139,6±7,6	1,7±0,1
6 ай	2,00±0,13	127,8±10,4	2,5±0,3
1 жыл	1,85±0,09	106,5±10,8	2,8±0,4
2 жыл	1,49±0,08	109,1±10,0	3,1±0,3
3 жыл	2,02±0,11	115,4±11,0	3,0±0,3
5 жыл	2,07±0,12	114,2±10,6	3,2±0,3
операциядан кейін	1,99±0,11	117,5±9,7	3,2±0,4
Склеротерапия:			
жүргізілгеннен кейін	2,55±0,09	147,6±6,2	1,4±0,1
6 ай	2,31±0,12	135,8±8,5	1,6±0,2
1 жыл	2,28±0,09	133,1±10,4	1,6±0,2
2 жыл	2,16±0,09	131,4±9,3	1,8±0,2
3 жыл	2,25±0,10	126,9±9,3	1,7±0,1
5 жыл	2,40±0,11	145,2±10,4	1,8±0,1
5 жылдан жоғары	2,03±0,09	137,0±8,7	1,7±0,2

тобындағы тиреоидты статусы сипаттайтын деректер 1 – кестеде берілген.

1-кестеде берілген деректерден көріп отырғанымыздай, қалқанша бездің түйінді патологиясына байланысты операция жасалған науқастардың барлық тобының қан құрамында тиреоидты гормондардың нақты төмендеуі мен тиреотропты гормондардың жоғарылауы болды. Аталмыш өзгерістердің сатысы жүргізілген орын басушы емге қарамастан, барлық жағдайда операция көлеміне тікелей байланыста болды. Сонымен, тиреоидэктомиядан кейін триотиронин құрамының орташа мөлшері бақылау көрсеткішінен 75,0% ($p<0,01$) төмен болды. Тироксин құрамының төмендеуі 67,8% ($p<0,01$) құрады. Осыған ұқсас тиреотропты гормон концентрациясының жоғарылауы анағұрлым маңызды болып, оның сатысы - 172,2% ($p<0,01$) құрады.

Субтотальды резекция болған науқастарда триотиронин құрамының азаю сатысы 69,1% құрады, тироксин – 58,9% ($p<0,01$ екі жағдайда да). Бұдан басқа тиреотропты гормондар құрамы екі есе асып кетті ($p<0,05$).

Органды сақтап қалу операцияларында топтар арасындағы аса маңызды айырмашылық триотиронин құрамы бойынша байқалды, өйткені тироксин концентрациясы көбіне жүргізілген орын басушы емнің көлемі мен адекваттылығына байланысты. 50% астам паренхиманы алып тастағанда да субтотальды резекциядағыдай T3 құрамының орташа мөлшері бақылау тобымен айырмашылық 64,1% ($p<0,01$). Дәл сол топта T4 құрамы бойынша сау адамдармен айырмашылық 48,2% ($p<0,01$) жетті, тиреотропты гормон құрамы 72,2% ($p<0,05$) артты.

Бездің 25-50% паренхимасы алынған науқастарда сондай гипотиреоидты жағдай байқалды, онда T3 концентрациясы бойынша айырмашылық 48,2% ($p<0,01$), T4 – 33,3% ($p<0,05$) құрады. T4 құрамын ескере отырып, аталмыш топта гипотиреоз субклиникалық болды деп қорытынды жасауға болады, бұл тиреотропты гормон концентрациясының (на 66,7%, $p<0,01$.) нақты жоғарылауымен бекітіледі.

25% аз паренхимасы алынған науқастарда тиреоидты концентрацияның азаю және тиреотропты гормонның көбеюіндегі нақты айырмашылыққа қарамастан, көптеген жағдайда гормоналды статусты эутиреоидты деп бағалауға болар еді. Склеротерапия жүргізілгеннен кейін сау адамдарда тиреоидты гормон құрамы бойынша маңызды айырмашылықтар байқалған жоқ.

2 - кестеде операция жасалғаннан кейінгі мерзімге байланысты тиреоидты статус ерекшеліктері туралы деректер берілген.

Кестеден көріп отырғанымыздай, тиреоидэктомия жасалған науқастарда зерттелген гормондар құрамы барлық тексерілген топтар арасында ең төмен ғана болып қоймай, операциядан кейінгі кезеңнің ұзақтығының жоғарылауы жөнінен төмендеуге нақты тенденциясы болды. Операциядан кейін 1 жыл өткенде осы топтағы триотиронин концентрациясы мардымсыз болды және тиреоидты статусқа әсер ете алмады. Тироксин құрамы операция жасалған сәттен бастап соңғы тексерілу мерзіміне дейін 4 есеге дейін төмендеді, тиреотропты гормон концентрациясы дәл осы дәрежеде артты.

Субтотальды резекция жасалған науқастарда тиреоидты статус көрсеткіштерінің динамикасы аса қолайсыз болды. Қалқанша бездің бастапқы өлшеміне қатысты тіпті шағын парнехима бөлігін сақтап қалу бақылау тобы көрсеткішіне қарағанда 20-25% деңгейде триотиронин өнімін сақтап қалуға мүмкіндік туғызады, зерттеудің барлық мерзімінде тиреоидэктомиядан кейін тироксин концентрациясы көрсеткішіне қатысты анағұрлым арттырады. Науқастардың басым көпшілігінде орын басушы ем жүргізуде операциядан кейінгі 3 жылға дейін тиреоидты статусы эутиреоз ретінде сипаттауға болады. Операциядан кейін тек қана 5 жыл өткенде және одан жоғары мерзімде субклиникалық гипотиреоз жиілігі анағұрлым ұлғайды.

Органды сақтап қалу операцияларын жүргізу барысында жалпы топта операциядан кейінгі барлық мерзімде тиреоидты гормон құрамының төмендеуі мен тиреотропты гормон құрамының жоғарылауы анықталмады, ал склероздаушы топта адекватты орын басушы емді жүзеге асыруда бірде – бір субклиникалық гипотиреоз жағдайы болған жоқ.

Қорытынды

1) Тиреоидэктомия жасалған науқастарда тиреоидты статусың үдемелі төмендеуі және тіпті жүргізілген орын басушы ем фонында операциядан кейінгі алшақ мерзімде гипотиреоз реттеуші механизмдер дисбалансының өсуі байқалады.

2) Қалқанша бездің қызметін атқарушы парнехиманың шағын ғана көлемін сақтау науқастардың тиреоидты статусын анағұрлым арттыруға ықпал етеді.

Әдебиеттер

1. Талантов В.В. Эндокринологический сб. Сушность. Экология и генетика в этиологии. Дефиниция // Проблемы эндокринологии. – 1989. - №4. – С.43-45.
2. Бубнов А.Н., Кузьмичев А.С., Гринёва Е.Н., Трунин Е.М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой сб. - СПб., 2002. - 96 с.
3. Ghelase F., Georgescu I., Ghelase S. et al. Present strategies in the diagnosis and treatment of thyroid diseases // Chirurgia. –

2001. – Vol.96(4). – P.355-365.
4. Суаришвили Н.З. Трунин Е.М. Дисфункция щитовидной железы после оперативного лечения диффузного токсического зоба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина.– 2007. - № 3.– С. 128 - 134.
5. Даньярова Л.Б. Доброкачественные заболевания щитовидной железы и репродуктивных органов и их гормональная взаимосвязь у женщин Семипалатинского региона: автореф. дис. канд.мед.наук. 14.00.03 – Алматы, 2000. – 25 с.